



Faculté de médecine de Sousse

Résidanat 2025

Dysphagie

Pr E Ben Jazia

Pr Ag S Mrabet

1. La dysphagie est:
 - A. Une douleur à la déglutition
 - B. Une sensation de blocage ou de gêne au passage du bol alimentaire
 - C. Synonyme d'aphagie
 - D. Différente de l'odynophagie
 - E. Une perte de l'appétit
2. La dysphagie « Lusoria » :
 - A. Est secondaire à une malformation de la crosse aortique
 - B. Est responsable d'une dysphagie chez les sujets âgés moins de 40 ans
 - C. Est souvent symptomatique
 - D. Peut se manifester par une dysphagie oropharyngée
 - E. Peut être responsable d'une compression extrinsèque de l'œsophage
3. Parmi les caractéristiques d'une dysphagie organique :
 - A- L'électivité pour les liquides
 - B- La corrélation entre le site de la dysphagie et le siège de l'obstacle
 - C- L'évolution intermittente
 - D- Le retentissement sur l'état général
 - E- Le pyrosis et les régurgitations associés
4. Parmi les éléments évocateurs de troubles moteurs œsophagiens, on trouve :
 - A- Age jeune
 - B- Altération de l'état général
 - C- Dysphagie prédominante sur les solides
 - D- Pyrosis
 - E- Régurgitations

5. Parmi les éléments cliniques qui orientent vers une dysphagie oropharyngée:

- A. Une difficulté à initier la déglutition
- B. Une localisation cervicale
- C. Des régurgitations nasales possibles
- D. Des fausses routes trachéales
- E. Une douleur rétro-sternale

6. Parmi les explorations demandées en première intention pour le diagnostic d'une dysphagie oropharyngée :

- A- L'endoscopie digestive haute
- B- La manométrie œsophagienne
- C- Un examen ORL
- D- Une nasofibroscopie
- E- Une évaluation neurologique

7. Parmi les causes d'une dysphagie oro-pharyngée, on trouve :

- A- La poly myosite
- B- La sclérose en plaques
- C- Le cancer de l'hypopharynx
- D- L'épi glottite
- E- Les tumeurs de la glotte

8. Le sphincter inférieur de l'œsophage :

- A- est un sphincter anatomique
- B- est une zone de 4cm située au niveau du bas œsophage
- C- est doté d'une pression de repos de 10-30mm Hg
- D- se relâche au début de la déglutition
- E- est exploré par la manométrie

9. L'apparition d'une dysphagie accompagnée de l'amélioration du pyrosis chez un patient présentant un reflux gastro-œsophagien ancien, est fortement évocatrice d' :

- A- une œsophagite peptique
- B- une sténose peptique
- C- un endobrachy-œsophage
- D- une sténose tumorale
- E- une hernie hiatale

10. La monométrie à haute résolution distingue une achalasie d'une hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage en montrant :

- A- Une pression de relaxation intégrée du sphincter inférieur de l'œsophage (SIO) > 15 mm Hg
- B- Une pression de relaxation intégrée du sphincter supérieur de l'œsophage (SSO) < 15 mm Hg
- C- Un apéristaltisme du corps de l'œsophage
- D- Une hypertonie du SSO
- E- Une hypotonie du SIO

11. Parmi les étiologies d'une dysphagie organique :

- A- Achalasie
- B- Cancer de l'œsophage
- C- Diverticule de Zenker
- D- Œsophagite mycotique
- E- Sclérodémie

12. L'œsophagite peptique :

- A- est une cause de dysphagie oropharyngée
- B- est due à un reflux gastro-œsophagien
- C- est située à la jonction du 1/3 supérieur et moyen de l'œsophage
- D- Peut se compliquer de sténose
- E- est une cause de dysphagie lésionnelle

13. L'œsophagite mycotique :

- A- est liée à une infection à Candida Albicans
- B- est favorisée par le diabète
- C- est souvent révélée par une odynophagie
- D- est souvent associée à une candidose buccale
- E- nécessite la réalisation des biopsies œsophagiennes pour retenir le diagnostic

14. Le diverticule de Zenker :

- A. Survient à un âge > 65 ans
- B. Se caractérise par une dysphagie cervicale intermittente
- C. S'associe à des régurgitations d'aliments non digérés
- D. S'associe à une Halitose
- E. est confirmé par endoscopie en première intention

15. Le syndrome de Plummer Vinson :

- A- se voit surtout chez la femme jeune de moins de 30 ans
- B- est un diverticule de l'œsophage cervical
- C- s'associe à une anémie ferriprive
- D- est un facteur de risque de cancer de l'hypopharynx et de l'œsophage cervical
- E- indique des biopsies systématiques lors de l'endoscopie

16. L'œsophagite à éosinophile :

- A- est une maladie très rare
- B- fait intervenir des mécanismes immuno-allergiques
- C- est responsable d'une dysphagie qui retentit rapidement sur l'état général
- D- donne un aspect « pseudo-trachéal » à l'endoscopie très évocateur du diagnostic
- E- est diagnostiquée par la mise en évidence d'une hyper éosinophilie intra-épithéliale au niveau des biopsies œsophagiennes

17. L'œsophagite médicamenteuse est favorisée par :

- A. Doxycycline
- B. AINS
- C. Biphosphonates
- D. Chlorure de potassium
- E. Statines

18. Concernant le cancer de l'œsophage :

- A- C'est le deuxième cancer digestif
- B- Il est plus fréquent chez l'homme
- C- Il est révélé par une dysphagie dans 70% des cas
- D- L'intoxication alcoolo-tabagique est un facteur de risque de l'adénocarcinome œsophagien
- E- Le type histologique le plus fréquent est le carcinome épidermoïde

19. Parmi les causes d'une dysphagie avec une endoscopie digestive haute normale, on retient :

- A- Le syndrome de Plummer Vinson
- B- L'œsophagite à éosinophile
- C- L'œsophagite mycosique
- D- L'anneau de Schatzki
- E- L'Achalasie

20. Parmi les causes d'une dysphagie fonctionnelle, on retient :

- A. Le syndrome de Plummer Vinson
- B. L'œsophage marteau piqueur
- C. L'œsophagite radique
- D. L'œsophagite à éosinophile
- E. L'anneau de Schatzki

21. Lesquelles de ces affections entraînent un trouble moteur œsophagien primaire ?

- A. Achalasie
- B. Maladie de Chagas
- C. Maladie des spasmes diffus de l'œsophage
- D. Œsophage « marteau piqueur »
- E. Tumeur infiltrante du cardia

22. Lesquelles de ces affections peuvent donner des troubles moteurs oesophagiens secondaires ?

- A. Amylose
- B. Polyarthrite rhumatoïde
- C. Lupus érythémateux disséminé
- D. Maladie de Chagas
- E. Spasme oesophagien

23. Concernant l'achalasie :

- A. C'est un trouble moteur œsophagien primaire
- B. C'est une cause de dysphagie lésionnelle
- C. Il peut à long terme se compliquer d'un méga-œsophage
- D. L'endoscopie digestive haute est le plus souvent anormale au début de la maladie
- E. La dysphagie est paradoxale et capricieuse

24. L'achalasie primitive de l'œsophage :

- A. est le trouble moteur primitif de l'œsophage le plus fréquent
- B. est une pathologie fréquente chez la femme
- C. est caractérisée par une dysphagie ancienne évoluant depuis plusieurs années
- D. est diagnostiquée par l'endoscopie digestive haute
- E. peut être déclenchée par les émotions ou les boissons froides

25. Dans l'achalasie, la dysphagie :

- A. est progressivement croissante pour les solides puis les liquides
- B. peut-être intermittente au début de l'évolution
- C. n'est pas constamment associée à une perte de poids
- D. ne s'associe pas à des symptômes de reflux gastro-œsophagien
- E. n'est jamais douloureuse

26. Parmi les anomalies retrouvées à la manométrie œsophagienne au cours de l'achalasie, on trouve :

- A. Absence de péristaltisme
- B. Contractions pouvant être d'amplitude importante
- C. Hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage
- D. Hypertonie du sphincter supérieur de l'œsophage
- E. Pression de relaxation intégrée du sphincter inférieur de l'œsophage >15mmHg

27. Les complications de l'achalasie sont :

- A. L'adénocarcinome de l'œsophage
- B. Les broncho-pneumopathies
- C. La candidose œsophagienne
- D. Le carcinome épidermoïde de l'œsophage
- E. L'œsophagite de stase

28. En présence d'un spasme diffus de l'œsophage, la manométrie œsophagienne montre :

- A. L'absence de péristaltisme
- B. Un défaut de relaxation de la jonction oesogastrique
- C. Une vitesse rapide de propagation du péristaltisme pour au moins 30% des déglutitions
- D. Des contractions prématurées pour au moins 20% des déglutitions
- E. Des contractions d'amplitude anormalement élevée pour plus que 20% des déglutitions

29. Parmi les explorations demandées de première intention devant une dysphagie :

- A. Transit baryté
- B. EOGD
- C. Scanner thoracique
- D. Manométrie œsophagienne
- E. Nasofibroscopie (dysphagie haute)

Cas clinique 1 :

Mr M.K âgé de 77 ans, tabagique à 30 PA consulte pour une sensation de blocage œsophagienne évoluant depuis trois mois de façon intermittente, initialement, prédominante sur les liquides. Actuellement elle intéresse les liquides et les solides et elle est améliorée par l'absorption d'une grande quantité d'eau au cours des repas. Le tout évoluant dans un contexte d'altération de l'état général.

30. Les éléments qui orientent vers une dysphagie fonctionnelle chez ce patient sont :

- A. L'amélioration par l'absorption d'une grande quantité d'eau
- B. L'évolution intermittente
- C. L'électivité pour les solides
- D. Le caractère paradoxal
- E. Le retentissement sur l'état général

31. Quel est le premier examen que vous demandez chez ce patient ?

- A. Endoscopie oeso-gastroduodénale
- B. Manométrie œsophagienne
- C. PH-métrie œsophagienne
- D. Transit œsophagien
- E. Scanner thoraco-abdominal

Le patient a eu une manométrie conventionnelle confirmant le diagnostic d'achalasie et un scanner thoraco-abdominal objectivant un nodule pulmonaire spiculé.

32. Parmi les éléments qui orientent vers une achalasie secondaire chez ce patient, on trouve :

- A. L'âge
- B. L'évolution depuis 3 mois
- C. Le caractère paradoxal de la dysphagie
- D. L'aggravation récente des symptômes
- E. L'altération de l'état général

33. Quel est le diagnostic le plus probable chez ce patient ?

- A. Achalasie primitive
- B. Adénocarcinome pulmonaire
- C. Carcinome épidermoïde pulmonaire
- D. Carcinome à grandes cellules pulmonaire
- E. Carcinome à petites cellules pulmonaire

Cas clinique 2 :

Monsieur A. âgé de 58 ans, consulte pour une dysphagie au niveau retro-sternal d'aggravation progressive évoluant depuis 4 mois. Il décrit d'abord une gêne pour le passage du pain et de la viande, puis pour les liquides. Il a perdu 8 kg en 3 mois. Il est tabagique à 33 PA. Il consomme de l'alcool de façon occasionnelle. Le patient rapporte un pyrosis et des régurgitations apparus depuis plusieurs années.

34. Comment caractérisez vous la dysphagie chez ce patient ?

- A. Dysphagie fonctionnelle
- B. Dysphagie organique
- C. Dysphagie oro-pharyngée
- D. Dysphagie d'origine neurologique
- E. Dysphagie œsophagienne lésionnelle

35. Que suspectez-vous chez ce patient ?

- A. Achalasie secondaire
- B. Sténose peptique
- C. Carcinome épidermoïde de l'œsophage
- D. Adénocarcinome de l'œsophage
- E. Diverticule de Zenker

36. Quel examen de première intention à visée étiologique demandez-vous chez ce patient ?

- A. Endoscopie digestive haute avec biopsies
- B. Transit œsogastroduodénal
- C. Scanner thoraco-abdominal
- D. Échoendoscopie
- E. Manométrie œsophagienne

- Bon travail-